GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

미주신경성 실신, 알면 예방하고 대처할 수 있습니다

자율신경이 과반응해 일시적으로 뇌혈류가 줄어드는 양성 실신 — 대부분 위험하지 않습니다

Vasovagal Syncope · Triggers · Counter-Pressure Maneuvers · Red Flags

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

실신 (Syncope) 이란

전반적 뇌혈류 감소로 인해 발생하는 일시적 의식 소실 — 평균 6~8초 내 회복

6 – 8초

뇌로 가는 혈류가 6~8초간 중단되면 누구든 의식을 잃을 수 있습니다 — 이후 자세를 눕히면 곧 회복됩니다.

왜 중요한가요

미주신경성 실신은 흔한 원인이지만, 위험한 심장성 실신과 구별해야 합니다. 유발 상황과 전조 증상을 살피면 어떤 검사가 필요한지 판단하는 데 도움이 됩니다.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ESC 2018 Syncope Guideline · ACC/AHA/HRS 2017

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

미주신경성 실신 (Vasovagal Syncope) 이란

자율신경 과반응으로 일시적 뇌혈류 부족이 일어나는 양성 실신

핵심 설명

자율신경이 갑작스러운 자극에 과민하게 반응해 혈관이 확장되고 심장 박동이 느려지면서 일시적으로 뇌혈류가 줄어드는 상태입니다.

보통 회복 시간

수 초 ~ 수 분 · 눕히면 빠르게 회복되며, 의식이 또렷해지는 시간도 짧습니다.

자세히

자율신경 반응으로 뇌혈류가 일시적으로 줄어드는 상태입니다. 넘어져 다치지 않도록 하고, 위험한 심장성 실신과 구별해야 합니다.

평생 경험 비율

3명 중 1명 · 평생 한 번은 경험할 수 있을 만큼 매우 흔한 양성 질환입니다.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ESC 2018 Syncope Guideline · 평생 경험 비율 자료

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

왜 생기나요? — 자율신경의 과민 반응

두 기전이 단독 또는 함께 작동해 뇌혈류 부족을 일으킵니다

혈관 억제 (Vasodepression)

교감신경 활동이 떨어지고 혈관이 갑자기 늘어지면서 혈압이 급격히 떨어집니다. 전신을 도는 압력이 약해져 뇌로 가는 혈류가 6~8초 이상 부족해지면 일시적 의식 소실이 발생합니다.

심장 억제 (Cardioinhibition)

미주신경이 우세해지면서 심장 박동이 갑작스럽게 느려지거나(서맥), 짧게 멈출 수도 있습니다(심장 일시정지). 심박출량이 떨어져 뇌로 보내는 혈류가 줄어들면서 의식이 흐려집니다.

두 기전의 혼합형

실제 임상에서는 혈관 억제와 심장 억제가 함께 일어나는 혼합형이 가장 흔합니다. 어느 쪽이 우세한지에 따라 환자가 느끼는 전조 증상과 회복 양상이 달라집니다.

결과 — 일시적 의식 소실

뇌혈류가 6~8초간 중단되면 누구든 의식을 잃습니다. 자세를 눕히면 중력 영향으로 혈류가 회복되어 곧 의식이 돌아옵니다 — 이것이 "쓰러짐"이 신체의 자기 보호 반응인 이유입니다.



궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ESC 2018 Syncope Guideline · Reflex syncope mechanism

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이런 상황에서 잘 생깁니다

유발 상황을 알아두면 미리 알아 실신을 예방할 수 있습니다

오래 서 있기

조회 시간, 만원 지하철, 식전 사진 촬영, 야외 행사로 오래 서 있을 때 피가 다리로 몰리면서 뇌혈류가 부족해 발생하기 쉽습니다.

감정 스트레스 · 통증

극도의 공포·놀람·당황, 채혈 장면 목격, 또는 극심한 통증·자극이 자율신경 균형을 깨뜨려 미주신경 반사를 과흥분시킵니다.

의료 행위 (보기)

주사를 맞거나 채혈할 때, 치과 진료, 응급실에서 피를 보는 상황에서 반사적으로 매우 흔하게 유발됩니다.

더운 환경

사우나, 한증탕, 무더운 여름날, 무리한 야외 활동 등에서 혈관이 확장되어 피가 다리에 더 몰리게 됩니다.

탈수 · 공복

수분 섭취가 부족하거나 장시간 굶은 뒤, 격한 운동 후 수분 부족으로 혈장이 줄면 혈관 내 압력이 잘 유지되지 않습니다.

상황 실신 (배변 · 배뇨)

야간에 화장실에서 배뇨·배변을 보거나, 또는 심한 기침을 거듭할 때 미주신경이 자극되어 발생하기도 합니다.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ESC 2018 Reflex Syncope · Trigger Classification

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

미주신경성 실신 vs 심장성 실신 구별 포인트

전조 증상·유발 상황·자세 등으로 위험도를 가늠할 수 있습니다

+ 미주신경성 실신 (양성)



- 전조 증상 있음 — 어지러움·식은땀·시야 흐림
- 오래 서 있기·통증·감정·더위 등 명확한 유발 요인
- 주로 오래 서 있을 때나 뚜렷한 유발 상황에서 발생
- 의식 소실 시간 짧음 (수 초~수 분)
- 눕히면 빠르게 회복, 후유증 없음
- 젊은 성인·여성에서 흔함

vs

! 심장성 실신 (위험)



- 전조 증상 없이 갑작스러운 의식 소실
- 운동 중·운동 직후 발생
- 누운 자세·앉아 쉬는 중에도 발생
- 흉통·두근거림·호흡곤란 동반 가능
- 심장 질환이나 돌연사 가족력
- 회복 후에도 무력감·혼동 지속 가능

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ESC 2018 Syncope Guideline · Cardiac vs Reflex Differential

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

전조 증상이 오면 즉시 이렇게! (PCM)

근육 반동 수기 (Physical Counter-Pressure Maneuver) — 들어두면 실신을 예방할 수 있습니다

다리 교차 후 근육 조이기

선 자세로 양 다리를 X자로 꼬고 배·엉덩이·허벅지 근육에 30초 이상 강하게 힘을 줘 혈류를 심장으로 보냅니다.

양손 깍지 끼고 세게 당기기

양손을 가슴 앞에서 깍지 끼고 서로 반대 방향으로 있는 힘껏 당깁니다. 고무공이나 수건을 쥐는 것도 좋습니다.

즉시 그 자리에 앉거나 눕기

가장 안전하게 머리를 보호하는 동작입니다. 혹시 의식을 잃더라도 부딪혀서 머리를 다치는 상황을 막아 줍니다.

앉거나 누워 쉬면서 회복

어지러우면 즉시 주변을 살펴 안전한 곳에 앉거나 눕습니다. 뇌혈류가 회복되어 곧 또렷해집니다.



PC-Trial RCT(2006) — 근육 반동 수기(PCM)는 단독 표준 치료만 받은 자에 비해 실신 재발을 39% 유의하게 감소시켰으며, 가장 안전한 1차 대처법으로 권장됩니다.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · PC-Trial RCT 2006 · ESC 2018 Class I Recommendation

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

매일 실천해 보세요 — 5가지 일상 습관

예방의 핵심은 충분한 수분과 적절한 염분, 그리고 자세 습관

물 하루 1.5~2 L

기상 직후·식전·운동 전후로 자주 나누어 마십니다. 심부전·신장질환으로 물을 제한 중이면 먼저 상담하세요.

적절한 염분 섭취

과도한 제한은 피하고 하루 소금 6~10g 권장 (ESC 2018 가이드라인 기준). 단, 고혈압·신질환이 있으면 의사 상담 후.

유발 상황 피하기

더운 환경(사우나 등) 회피, 공복 상태로 장시간 서 있지 않기. 만원 지하철 등 밀폐·고온 환경을 짧게 유지.

단계적 기립 주의

눕거나 앉은 자세에서 일어날 때는 30초 정도 천천히. 서기(중간), 짧은 정지(잠깐), 완전 기립 순으로 시야 안정 후 이동.

압박 스타킹 / 복대 활용

정맥 환류 개선으로 피가 다리에 몰리는 부분을 막아 줍니다. 실신이 자주 재발하는 분, 수분 섭취만으로 부족한 분에게 권장.

"약보다 더 중요"

약물 처방 전 먼저 시도해야 할 핵심 1차 치료입니다. 매일의 작은 습관이 실신 빈도와 강도를 의미 있게 줄여 줍니다.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ESC 2018 Syncope · Lifestyle modification first-line

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이런 실신은 위험합니다 (Red Flags)

운동 중·누운·앉은 자세·전조 없이 쓰러졌다면 바로 응급실에서 평가 — 가족 급사 병력은 심장 정밀 검사



운동 중 실신 — 휴식 시 X, 운동 중 발생

운동 직후가 아닌 운동하는 도중에 쓰러지는 경우, 심장 구조 이상이나 부정맥 등 치명적인 구조적 심장 질환을 의심해야 합니다.

누운 자세에서 실신

일반적인 반사성 실신은 주로 서 있을 때 발생합니다. 누워 있거나 앉아 있는 자세에서의 실신은 심장성(부정맥) 원인일 가능성이 높습니다.

전조 증상 없는 갑작스러운 실신

어지러움·식은땀·메스꺼움 등 어떠한 경고 신호도 없이 수 초간 쓰러지는 경우, 심한 서맥이나 완전 방실차단 등 위험한 상태일 수 있습니다.

가족 중 급사 병력 (55세 미만)

가족이나 친척 중 젊은 나이에 원인 모를 심장 마비로 사망한 분이 있다면, 긴 QT 증후군 등 유전성 심전도 질환의 가능성을 반드시 평가해야 합니다.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ESC 2018 High-Risk Features · Cardiology referral indications

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

어떤 검사를 받나요? — 단계적 접근

대부분 1차 검사만으로 충분히 진단 가능 — 위험 신호가 있을 때만 2차 검사

상세 병력 청취

유발 상황, 전조 증상, 자세, 목격자 진술을 종합 — 이것만으로 미주신경성 실신을 70% 이상 진단할 수 있습니다.

신체 진찰

심잡음, 누운·선 자세 혈압, 신경학적 이상 여부를 진찰합니다. 기립 후 3분간의 혈압·맥박 변화 비교가 핵심.

12 유도 심전도 (ECG)

부정맥, 전도 이상, 유전성 심질환 등 심장성 실신을 감별하기 위한 필수 기본 검사입니다.

기립 경사 검사 (HUT)

기울어지는 침대에서 혈압·맥박 변화를 관찰. 미주신경성 실신을 객관적으로 재현하기 위한 검사입니다.

심장 초음파 / 24시간 홀터

초음파로 구조적 심장 질환을 평가. 24~48시간 홀터 모니터링으로 일상에서의 부정맥 동반 여부를 확인합니다.

이식형 사건기록기 (ILR)

원인 불명 재발성 실신에서 부정맥 검출용으로 피부 아래에 작은 기기를 삽입 — 매우 드문 경우에만 적용.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ESC 2018 Diagnostic Algorithm · Class I Tests

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘 꼭 기억할 핵심 8가지

미주신경성 실신은 대부분 위험하지 않지만, 알아두면 예방하고 위험 신호를 구별할 수 있습니다

01 미주신경성 실신은 대개 위험하지 않지만 원인 감별이 필요한 실신입니다

02 유발 상황(더위·통증·오래 서기 등)을 알아 피하기가 핵심

03 전조 오면 즉시 그 자리에 앉거나 눕기 + 다리 꼬기

04 물을 충분히 마시고 일어날 때는 3단계(눕→앉→서)로

05 근육 반동 수기(PCM)로 재발 39% ↓ (PC-Trial)

06 압박 스타킹·복대로 정맥 환류 개선 가능

07 운동 중·누운·앉은 자세·전조 없음 → 바로 응급실

08 젊을수록 가족 급사 병력 있으면 심장 정밀 검사로

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · Daily action plan — recognise triggers, apply PCM, identify red flags

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

투약 후 실신은 알레르기 반응과도 구별합니다

심장성 실신 감별에 더해, 약물·시술 직후의 동반 증상을 확인합니다

피부·호흡·배 증상

투약이나 시술 뒤 쓰러지면서 두드러기·부종, 쌕쌕거림·호흡곤란, 복통·구토·설사 등이 함께 생기면 즉시 의료진에게 알립니다.

맥박 변화도 함께 살피기

강의에서는 미주신경성 실신의 서맥과 아나필락시스의 빈맥을 감별 단서로 설명했습니다.

검사보다 응급 대응

아나필락시스는 혈압 저하와 실신을 일으킬 수 있습니다. 동반 증상과 투약 시점을 알려 응급 평가를 받습니다.

증상을 말할 때는 투여한 약과 증상이 시작된 시점도 함께 알려 주세요.

아산 28회 연수강좌 — 약물 알레르기 진단과 관리의 실제(김태범)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다 · 일어설 때 핑 도는 어지럼은 기립성 어지럼 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

환자와 보호자를 위한 설명자료입니다. 진단과 처방은 담당 의료진과 상의하세요.

참고한 자료

ESC 2018 실신 지침 · ACC/AHA/HRS 2017 실신 지침

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요